Medicinska etika v pediatriji

Štefan Grosek
Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, Kirurška klinika Univerzitetni klinični center Ljubljana
Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Katedra za pediatrijo

Medicinska etika se ukvarja z uvajanjem etike in morale v vsakdanje delo zdravstvenih delavcev. Vse od Hipokrata dalje so največkrat odločitve o zdravljenju ležale na zdravnikovih ramenih. V zadnji polovici 20. stoletja so družbena gibanja v ospredje odločanja postavila posameznika kot glavnega subjekta pri skrbi za lastno zdravje in zdravljenje in zamajala dotedanjo paternalistično odločanje zdravnikov namesto bolnikov. Odločanje o poteku in naravi zdravljenja je sedaj, po poučitvi s strani zdravnika, prevzel bolnik sam ali njegovi zakoniti zastopnik.

Uvod

Etika je znanost o morali. Medicinska etika se ukvarja z uvajanjem etike in morale v vsakdanjo medicinsko prakso (1). Ko govorimo o morali mislimo na to kako družba kot skupnost ocenjuje in sprejema kaj je prav in kaj narobe (1). Splošna ali občečloveška morala je za vse ljudje univerzalna; kot npr. ne kradi, ne ubijaj, ne laži, itd (2). Posebne moralne vrednote so značilne za določene etnične, kulturne ali posamezne skupine.

Razhajanja v morali se začnejo tedaj, ko se mora oseba odločati med dvema nasprotujočima ali različnima dejanjema in ko ne more izvesti obeh. V sodobni pediatriji se vsakodnevno srečujemo z medicinsko tehnologijo, aparaturami, zdravili, kirurškimi tehnikami, ki ohranjajo življenja, popravljajo prirojene in pridobljene napake in poškodbe, preprečujejo in zdravijo akutne in kronične bolezni, zato je poznavanje etičnih načel in njihova uporaba osnova za dobro klinično delo. Kdaj in kako uporabiti en način zdravljenja pred drugim, pogosto predstavlja ne samo strokovno ampak tudi etično oziroma moralno dilemo. Ko smo v dvomu je dobro, če poznamo modele etičnega odločanja.

Modeli odločanja ob etični dilemi

Ameriška bioetika, Beauchamp in Childress, sta postavila temelje sodobni medicinski etiki na osnovi štirih temeljnih načel, avtonomije posameznika, dobrodelnosti, neškodljivosti in pravičnosti (1). Ko imamo etično dilemo nam ta načela pomagajo pri njeni razrešitvi (*metoda principlizma*). Poleg metode principlizma sta najbolj razširjena in uporabna ravno »*model štirih oken*« (angl. Jonsen-Siegler-Winsladov four boxes model) (3) in pa »*model moralnega razmisleka ali refleksije*« (angl. moral case deliberation), pri katerem gre za identifikacijo in tehtanje vpletenih vrednot in dolžnosti ukrepanja (4).

Medicinska etika v pediatriji

Medicinska etika nima odgovorov na vsa vprašanja, postavlja samo neko osnovo za odločanje pri delu z bolniki. Pri zdravljenju otrok uporabljamo načelo dobrodelnosti in neškodljivosti pri zdravljenju in negi, ki mora biti v otrokovo največjo korist (1,5).

Naslednji dve načeli sta načelo avtonomije posameznika in načelo pravičnosti (1). Njim so podrejena še druga načela; načelo dvojnega učinkovanja zdravil in načelo spoštovanja človekovega

dostojanstva (1). Pri skrbi za bolne otroke nas pri vsakdanjem delu vežejo kodeksi medicinske deontologije. Načelo dobrodelnosti oziroma največje otrokove koristi je vgrajeno v zdravniškem kodeksu in kodeksu medicinskih sester ter v Zakonu o pacientovih pravicah in Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Pri tem ne smemo pozabiti, da nam nasproti medicinski in moralni presoji stoji tudi pravna presoja.

Za zdravljenje se bolniki odločajo avtonomno sami ali v primeru otrok preko staršev ali zakonitih zastopnikov. Za avtonomno odločanje morajo biti sposobni razumeti zdravnikove razloge, zakaj je potrebno zdravljenje in tudi posledice, če se za predlagano zdravljenje ne odločijo. Če se bolniki oziroma starši ali zakoniti zastopniki odločijo, da ne želijo zdravljenja, je pa stanje s strani zdravnika ocenjeno kot nujno in zdravnik ni prepričan, da se bolnik ali zakoniti zatopnik zaveda posledic nezdravljenja, se odločamo po kriteriju največje koristi za bolnika. Zakon o pacientovih pravicah uporablja dikcijo »največja zdravstvena korist« za pacienta, v 3. členu, kjer govori o načelih, ki se uporabljajo pri uresničevanju pravic pacientov po tem zakonu in v 29. členu, kjer govori, kdaj se lahko opravijo posegi oziroma zdravstvena oskrba brez privolitve pacienta (6).

Etika pediatričnega intenzivnega zdravljenja

Delo v pediatrični intenzivni enoti je za zdravnika in medicinsko sestro vsak dan velik strokovni izziv, ki žene zdravstvene delavce k predanemu delu, istočasno pa lahko predstavlja tudi veliko moralno breme. Pogosto je veliko breme pogojeno z nezmožnostjo, da delamo tako, kot smo si zamislili, da je za bolnika najboljše. Tako zdravnik npr. ne more izvajati zdravljenja v največjo korist bolnika zaradi npr. različnih mnenj o zdravljenju med zdravniki, zdravniki in bolnikom ali starši oziroma njegovimi zakonitimi zastopniki, zahtev bolnika ali svojcev po zdravljenju, ki po medicinskem vedenju in znanju ne bi prineslo izboljšanja ali ozdravitve in zato ni opravičljivo. Preobremenjenost in preutrujenost zaradi pomanjkanja zdravstvenega osebja, finančnih omejitev in s tem povezane izgorelosti na delovnem mestu lahko hitro privedejo do stisk in moralnih dvomov zaposlenih v zdravstvu. V enoto intenzivne terapije sprejemamo bolnike pri katerih je prišlo do odpovedi življenjsko pomembnih organov, ki so s stališča intenzivnega zdravljenja reverzibilna oziroma ozdravljiva (5,7,8). Pogosto na začetku zdravljenja ne vemo ali je bolezensko stanje reverzibilno ali ni, zato se sprejemajo bolniki za katere sicer predvidevamo, da so njihova stanja z medicinskega stanja rešljiva, pa se kasneje izkaže, da niso. Včasih se sprejmejo na intenzivno zdravljenje bolniki, da bi še zadnjič poizkusili določeno zdravljenje ali zdravilo, včasih tudi iz razloga, ker tako zahtevajo sorodniki oziroma zakoniti zastopniki.

Pri odločanju o začetku ali nezačetku intenzivnega zdravljenja se odločamo s premislekom, da je včasih bolje začeti zdravljenje in ga kasneje tudi prenehati, kot pa ga sploh ne začeti. Tako zdravljenje imenujemo t. i. »poskusno zdravljenje«. Če po določenem obdobju ne pride do nobenega izboljšanja, ampak se stanje poslabšuje, se pogovorimo o prenehanju zdravljenja. Kot odgovor na zgornjo dilemo se je razvil koncept brezupnosti zdravljenja (9). Brezupnost je tisto stanje, ko bolan človek pride do točke, na kateri nobeno zdravljenje več ne izboljša bolnikovega stanja (1). O etiki ravnanja z umirajočimi imamo tudi pri nas napisano mnenje Komisije za medicinsko etiko Republike Slovenije (10).

Odločamo se lahko med različnimi možnostmi prenehanja zdravljenja in sicer, da ne bomo več oživljali (angl. »do-not-resuscitate«, DNR), ki v osnovi spada med ukrepe opustitve zdravljenja (angl. withholding). Opustitev zdravljenja pomeni, da intenzivnega zdravljenja sploh ne bomo začeli, oziroma, če je bilo že začeto, da ne bomo dodajali aparatur ali zdravil, ki podaljšujejo življenje.

Če smo začeli z zdravljenjem, ga lahko tudi prekinemo, s tem, da prenehamo dajati zdravila, umetno predihavanje ali podporo srca z napravami za mehansko podporo srca, ledvic, jeter, itd. (angl. withdrawing). Raziskave so pokazale, da je pomemben pravilen delež odločitev o odtegnitvi zdravljenja med DNR, opustitvijo in prenehanjem. Zato je potrebno vsak primer odločanja posebej obravnavati, zlasti nekatere skupine bolnikov, kot so npr. bolniki z malignimi obolenji, ekstremno majhni nedonošenčki, bolniki v visoki starosti, bolniki s kroničnimi progresivnimi boleznimi, da ne bi bili premalo odločni v zdravljenju, kar je poznano kot izraz »samouresničujoča prerokba« (angl. self-fulfilling prophecy). Odklanjanje zdravljenja določenih skupin bolnikov, ker so preveč nezreli, prestari, itd, zaradi racionalizacije zdravljenja tudi zahteva pravilen etični razmislek

Etika uvajanja novih metod zdravljenja in raziskovalnega dela

Nova odkritja v medicini, na področju zdravil, naprav, cepiv, kirurških tehnik in diagnostičnih postopkov nas silijo, ne samo zdravnike ampak tudi bolnike, da bi jih čimprej uporabili pri vsakdanjem delu. V mnogih medicinskih centrih se ustanavljajo oddelki za »*translacijsko medicino*«, ki naj bi čim hitreje uvedli nove načine zdravljanja v vsakdanjo klinično delo (angl. »*bench-to-bedside« approach*). Tako hitro uvajanje, kjer so tesno povezani med seboj raziskovalci, kliniki in proizvajalci, mora biti pazljivo in natančno etično ovrednoteno, da ne bi prišlo do etičnih dilem in tudi konflikta interesov na škodo bolnikov, kar se je v praksi že večkrat pokazalo.

Znanje v medicini se je največkrat prenašalo in se še prenaša z učitelja-starejšega zdravnika na mlajšega zdravnika. Tudi novi načini in postopki zdravljenja se pogosto prenašajo med ustanovami in zdravniki na osnovi učenja ali na osnovi prenašanja poročil uspešnega zdravljenja, ki so bila predstavljena na strokovnih in znanstvenih sestankih. Tukaj moramo biti posebej pazljivi, da uvajanje novih metod zdravljenja ne gre na škodo pacientov, posebno pri tehnikah, ki zahtevajo daljšo dobo učenja, posebno v primerih, če je število bolnikov manjše, kot v ustanovi, kjer so uvedli novo metodo. Pri vrednotenju rezultatov nove operativne tehnike ali diagnostične metode je potrebno pogledati kratkoročne in dolgoročne učinke nove metode zdravljenja ali diagnostike, ker lahko, da bi bili kratkoročni učinki boljši, vendar dolgoročno slabši.

Pri raziskovalnem delu posebno v intenzivni medicini so bolniki pogosto vključeni v razne medicinske raziskave. Če bolnik ne more sam odločati, se namesto njega po poučitvi odločajo sorodniki oziroma zakoniti zastopniki in v primeru otrok, njihovi starši ali zakoniti zastopniki. Namen privolitve po poučitvi je zagotoviti posamezniku, da lahko kontrolira svoje odločitve glede vključevanja v raziskave in da so istočasno zdravljeni po načelih največje koristi za bolnika. Vendar se bolniki pogosto ne spomnijo, da so bili povabljeni in vključeni v raziskave ali pa so jezni in razočarani, če njihovi otroci niso bili izbrani v skupino, ki je zdravljena z novim zdravilom ali metodo.

Številne etične dileme se pojavljajo praktično na vseh področjih pediatrije. Pri vsakem uvajanju nove metode moramo narediti moralni razmislek (deliberacijo) kaj prinaša nova metoda dobrega in kaj slabega. Tako se moramo vprašati kako pristopati k zdravljenju bolezni, kjer je možnost ozdravljenja visoka, vendar gredo posledice ozdravitve lahko na račun težkih stranskih škodljivih učinkov. Kako se odločati v največjo korist otroka v zvezi z novimi kirurškimi načini zdravljenja lahko prikažemo na primeru uvajanja bariatrične kirurgije v zdravljenju ekstremne debelosti otrok, ki se ne morejo sami odločati za ali proti posegu. Tu je potreben poglobljen etični razmislek, ker so vzroki za debelost večplastni in zdravljenje debelosti z različnimi kirurškimi tehnikami v občutljivem otroškem obdobju za seboj potegnejo številne zaplete, ki so lahko čustveni, razvojni in tudi kirurški.

V to skupino spadajo tudi določene ritualne operacije, kot npr. cirkumcizije. Etične dileme se pojavljajo tudi pri odločanjih o zdravljenih otrok, ki se rodijo s hudimi kromosomskimi napakami s številnimi napakami in težkim razvojnim in motoričnim zaostankom, kot primer navajamo trisomijo 18. Ali naj staršem in otroku s trisomijo 18 ponudimo samo paliativno oskrbo ali pa naj sledimo želji staršev in redko tudi zdravnikov, ki želijo, da se naredi vse za otroka vključno z zahtevnimi operacijami na srcu. Posebno poglavje je odločanje za ali proti cepljenju proti nalezljivim boleznim, kjer imamo vedno več zadržkov s strani staršev glede cepljenja njihovih otrok.

Zaključek

Medicinska etika je vgrajena v vsakdanje delo z bolniki. Pri zdravljenju otrok, uvajanju novih metod moramo biti še posebej pazljivi, da zdravljenje poteka po načelu največje koristi za otroka in najmanjše škode. Modeli etičnega odločanja so nam v pomoč, ko se moramo odločati za ali proti zdravljenju z določenim zdravilom ali načinom zdravljenja ali se soočamo z odklanjanjem staršev ali siljenjem za določeno zdravljenje.

Literatura

1. Beauchamp TL, Childress JF. Principles of Biomedical Ethics. Oxford: Oxford University Press, 2009: 417.
2. Shockenhoff E. Etika življenja: temeljna načela in konkretna vprašanja. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; 2013. p. 571.
3. Schumann JH, Alfandre D. Clinical ethical decision making: the four topics approach. Semin Med Pract 2008; 11: 36–42.
4. Grosek Š. Kako razumeti načelo "največje koristi" oziroma "najboljšega interesa" v neonatalni in pediatrični intenzivni enoti pri otroku, ki postane brezupno bolan. Isis 2012; 21: 51-9.
5. Gracia D. Ethical case deliberation and decision making. Med Health Care Philos 2003; 6: 227-33.
6. Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP) Uradni list Republike Slovenije št. 15 / 2008 ISSN 1318-0576 Leto XVIII: 1045-1062.
7. Primožič J. Etična vprašanja pri kritično bolnih otrocih. In: Grosek Š, ed. Zbornik predavanj I. izobraževalni seminar Medicinska etika v intenzivni medicini; 2011 mar; Ljubljana: Univerzitetni klinični center, Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo Kirurške klinike; 2011: 5-13.
8. Grošelj U, Oražem M, Trontelj J, Grosek Š. Etične dileme ob koncu življenja v intenzivni medicini. Zdrav Vestn 2013; 82: 589–601.
9. Burns JP, Truog RD. Futility: a concept in evolution. Chest. 2007;132: 1987-93.
10. Trontelj J. Stališče Državne komisije za medicinsko etiko o ravnanju z umirajočimi in o evtanaziji. Zdrav Vestn 1997; 66: 269-70.